家庭医療専門医制度の改訂

ポートフォリオが 20 → 16 になった、何が変わるか

新・家庭医療専門医制度とかかりつけ医機能報告（2026）

参考文献

2026-03-27 ・ AI(Claude)作成・主な出典は原典で確認

このセッションで持ち帰ってもらう3つ

1. ポートフォリオの **何が減って何が残ったか** を言える
2. **学会発表要件** の緩和と学術大会の意味を理解する
3. **かかりつけ医機能報告制度** が自分の診療にどう関わるかを1つ挙げる

*約束: 制度の話は退屈に見えがちですが、**「自分の1年がどう変わるか」** の視点で読みます。*

0. なぜ今この話か

- 新・家庭医療専門医制度で **ポートフォリオ領域数が 20 → 16 に削減**（2 割減）
- 学会発表も **3 件以上 → 2 件以上** に緩和（日経メディカル報道）
- 第 17 回 JPCA 学術大会は **2026 年 5/29-31 に国立京都国際会館で開催済み**
- かかりつけ医機能報告制度（2025/4 施行）の初回報告は **2026/1-3** に実施され、都道府県の公表が始まっている

PART 1

ポートフォリオの変化

PART 1・ポートフォリオの変化

20 → 16、3件 → 2件

ポートフォリオ領域 20 → 16
学会発表 3 件 → 2 件

PART 1・ポートフォリオの変化

数字で見る

領域数と学会発表

旧		新
ポートフォリオ領域数	→	ポートフォリオ領域数
20	→	16
学会発表		学会発表
3 件以上	→	2 件以上

ID（インストラクショナルデザイン）の観点では「量を減らして質を上げる」改訂

期間: 3 年（変わらず）

出典: JPCA 告知（2024-06-13）／日経メディカル報道（学会発表）

何が問われているのか

- 「こなす」から「深く学ぶ」へ
- 1 領域あたりの記述・振り返りの質が問われる
- 指導医も「印鑑を押す」ではなく「対話する」設計に
- 「ポートフォリオが形骸化していた」という現場感への応答

PART 1・ポートフォリオの変化

研修医側の影響

- 書く領域は減った → **1 本あたりのボリューム**が増える覚悟
- 学会発表は 2 本 → 何を残すかの**戦略性**が上がる
- ポートフォリオ指導は**指導医との対話時間**が鍵
- 「埋める」より「語れる」記述を目指す

PART 2

学会発表 3→2 の読み方

量より質へ

- 学会発表の**バッジ集め**から**意味のある 2 本**へ
- JPCA 本大会・地方会・英語発表のバランスを考え直す時期
- 「領域を網羅する」より「**自分の臨床疑問 1 本を深掘る**」が評価される

JPCA 学術大会 2026（京都）

- 会期: 2026 年 5/29 - 5/31（開催済み）
- 会場: 国立京都国際会館
- テーマ:「つながる、つなげる。つなげる、つながる。」
- 次回以降の大会も、**制度と教育の接点**を考える機会になる

PART 3

かかりつけ医機能報告制度

制度の骨格

- 2025 年 4 月施行
- 医療機能情報提供制度と同じ時期（毎年 1-3 月）に報告
- 初回報告は **2026 年 1-3 月** に実施済み
- 特定機能病院と歯科を除く全ての病院・診療所が報告
- 都道府県が結果を公表（例: 神奈川県は 2026/10/19 公表、報告率 87.1%・2026/9/30 時点）

研修医の診療とどう繋がるか

- 慢性疾患の継続管理 → 報告指標に関わる
- 在宅医療・多職種連携 → 同上
- ACP・意思決定支援 → 価値観対話が記録に残る意味
- 「外来を回すだけ」の診療は可視化されにくい

報告指標と日々の診療

- 「どう記録されるか」を意識して書く
- カルテに**機能報告に繋がる視点**を 1 行入れる
- 「継続管理 / 在宅 / 連携 / ACP」のキーワードで自分の 1 週間を振り返る

PART 4

自分の１年をどう変えるか

3 つの問い

- ポートフォリオで**深く書きたい領域**はどれか？
- 学会発表 2 本は **何と何** にするか？
- かかりつけ医機能報告の指標で、**自分が強い領域**はどこか？

指導医との対話で使える一言

- 「今の記述で、**後輩が読んで学べる**ものになっているか？」
- 「この症例で **自分が一番驚いたこと** を書けているか？」
- 「もし外部評価者が読んだら、**何を疑問に思うか**？」

今週やってみてほしい1つ

ポートフォリオの**未提出領域を 1 つ**選んで、
「1 症例 × 3 行の記述」を**できそうなときに**書いてみてください。

- 3 行は「起きたこと / 自分が考えたこと / 次にどう変えるか」
- これが**指導医との対話の種**になる

持ち帰り — recap

1. 新専門医制度: ポートフォリオ **20→16**、学会発表 **3→2**。量より質へ
2. JPCA 学術大会（2026 年 5/29-31 京都）は開催済み。次回以降も**制度と教育の接点**を考える機会
3. かかりつけ医機能報告: 自分の診療の**見え方**を変える。記録で可視化する意識

参考文献

学会・制度（一次情報）

日本プライマリ・ケア連合学会（JPCA）公式
https://www.primarycare-japan.com/
JPCA: 新家庭医療専門医ポートフォリオ領域改訂のご案内（2024-06-13, 20 → 16 領域, 2024 年度修了者から適用）
https://www.primarycare-japan.com/news-detail.php?nid=890
日経メディカル: 専門医制度解説（領域 20→16、学会発表 3 件以上→2 件以上）
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t325/202406/584715.html

かかりつけ医機能報告制度

厚生労働省 かかりつけ医機能報告制度（ガイドライン・報告マニュアル）
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123022_00007.html
神奈川県 令和7年度かかりつけ医機能報告の公表（2026-10-19）
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f6z/r7kakaritsuke.html